

ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Rapport d'Analyse Respiratoire et Oxymétrie

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

☎ 0796 222 597 / 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT & CONTEXTE CLINIQUE

Nom :	Selmane Saliha	ID Patient :	20260913-135
Genre :	Féminin	Période enreg. :	23 :33 :00 – 08 :58 :30 (Nuit)
Âge :	58 ans (Née le 30/05/1968)	Durée totale :	565,5 min (9h 25min)
Taille / Poids :	157 cm / 81 kg	Durée valide :	565,5 min (100,0%)
IMC :	32,9 kg/m ²	Date d'examen :	13 Septembre 2026
Motif / Contexte :	Examen ORL révélant un rétrécissement de l'isthme pharyngé.		



Scanner pour accéder au tracé complet et dossier numérique

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE POLYGRAPHIQUE

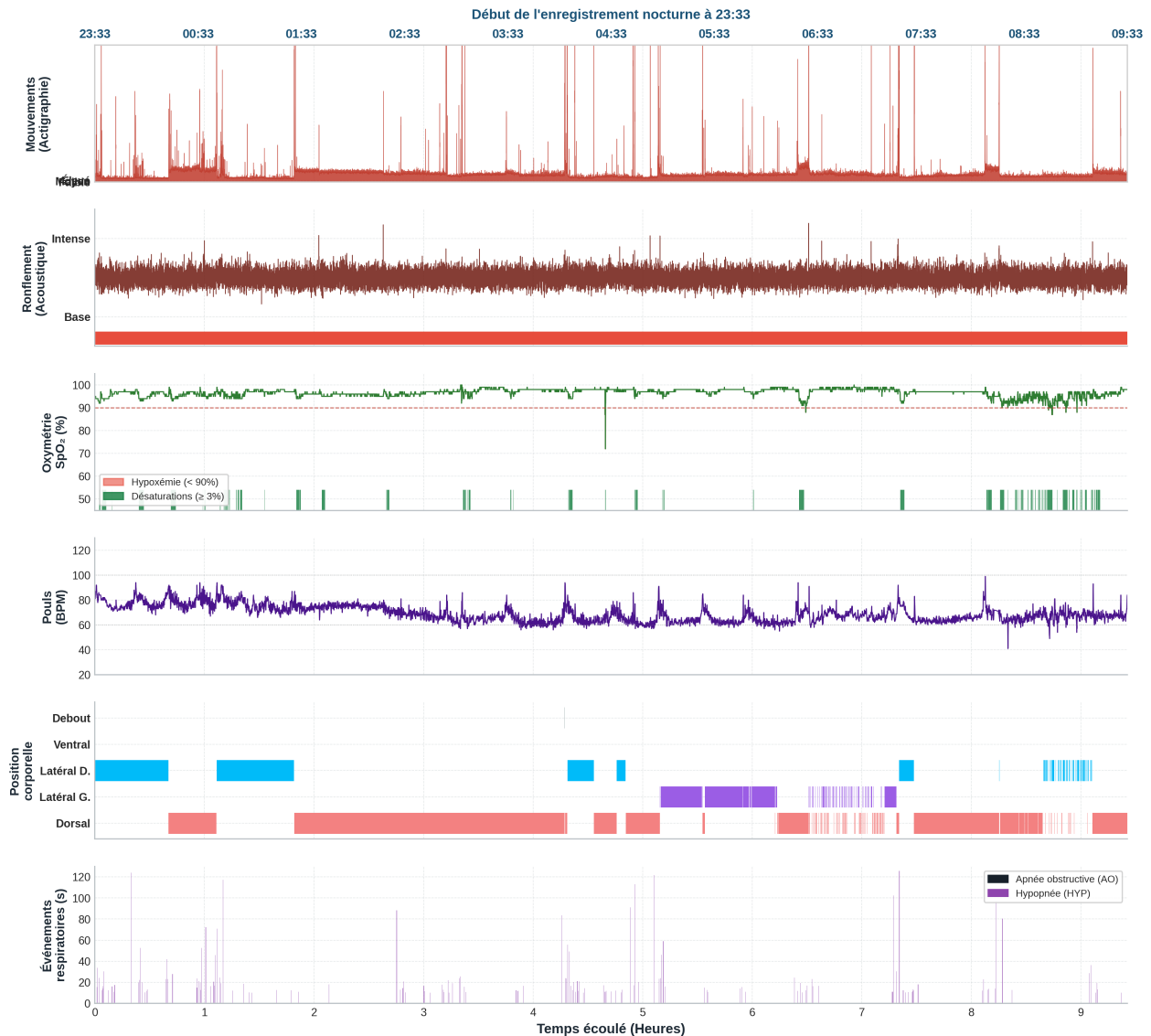


FIGURE 1 – **Enregistrement continu multicanal nocturne (23 :33 – 08 :58)** : Mouvements corporels (Actimétrie), Débit aérien nasal, Oxymétrie de pouls (SpO₂), Fréquence cardiaque, Encodage des postures et Histogramme temporel des événements respiratoires.

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DU SOMMEIL

2.1. DISTRIBUTION POSTURALE ET IMPACT VENTILATOIRE

TABLE 1 – Événements respiratoires et désaturations selon la position corporelle

Position	Durée (min)	%	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Total Resp.
Dorsale (SUP)	347,1	61,4%	15	0	0	0	37	6,4	15
Ventrale (PRO)	0,0	0,0%	0	0	0	0	0	—	0
Côté gauche (LAT-G)	88,6	15,7%	1	0	0	0	2	1,4	1
Côté droit (LAT-D)	129,7	22,9%	4	0	0	0	20	9,3	4
Debout (STAND)	0,1	0,0%	0	0	0	0	0	—	0
Total / Moyenne	565,5	100%	20	0	0	0	59	6,6	20

2.2. CINÉTIQUE DE L'OXYMÉTRIE DE POULS (SpO₂)

TABLE 2 – Paramètres oxymétriques détaillés et cinétique du signal

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Norme / Référence
SpO ₂ maximale (%)	99	95 – 100 %
SpO ₂ minimale (Nadir oxymétrique ponctuel)	87	≥ 90 %
SpO ₂ moyenne (%)	97	≥ 95 %
Durée cumulée des désaturations relatives (min)	38,2	6,8 % de l'examen
Durée moyenne d'une désaturation	38,8 s	—
Durée maximale d'une désaturation	120,0 s	< 20 s
Nombre total d'événements de désaturation (DO)	59	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO global)	6,6 /h	< 5 /h
Index de Désaturation en Décubitus Dorsal	6,4 /h	< 5 /h
Charge Hypoxique (Canonical Azarbarzin / All-Flow)	14,21 %·min/h	< 20 %·min/h
Temps passé sous 95% de SpO ₂ (min)	68,0	12,0 % du temps total
Temps sous 90% de SpO ₂ (T90 en min)	0,8	0,1 % du temps total
Temps passé sous 85% de SpO ₂ (min)	0,0	0,0 % du temps total
Temps passé sous 80% de SpO ₂ (min)	0,0	0,0 % du temps total

2.3. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (APNÉES & HYPOPNÉES)

TABLE 3 – **Caractérisation et indexation ventilatoire**

Catégorie Événementielle	Nombre	Index (/h)
Apnées (Total : 0)		
Apnées Obstructives (SAOS)	0	
Apnées Centrales (AC)	0	
Apnées Mixtes (AM)	0	
Durée cumulée des apnées	0,0 min	(0,0% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	—	—
Hypopnées (Total : 20)		
Nombre total d'hypopnées	20	2,1
Durée cumulée des hypopnées	7,8 min	(1,4% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	23,2 s	53,8 s
Synthèse Ventilatoire Globale		
Nombre cumulé d'événements respiratoires	20	—
Durée totale cumulée sous événement (min)	7,8 min	1,4 % de l'enregistrement
Durée moyenne d'un événement respiratoire	23,2 s	—
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	—	2,1 /h
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	—	6,6 /h
Respiratory Disturbance Index (RDI)	—	2,1 /h

3. TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE

TABLE 4 – Récapitulatif des biomarqueurs polygraphiques et neuro-végétatifs

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
SpO ₂ moyenne (%)	97 %	SpO ₂ minimale (%)	87 %
IDO global (/h)	6,6	IDO dorsal (/h)	6,4
Charge Hypoxique Estimée	14,21 %·min/h	RDI (/h)	2,1
Nombre SAOS	0	Nombre Apnées Centrales	0
Nombre Apnées Mixtes	0	Total Apnées	0
Index d'Apnées (IA /h)	0,0	Nombre d'Hypopnées	20 (IH : 2,1/h)
IAH global (/h)	2,1	Mouvements (actimétrie)	2116
FC moyenne (bpm)	69	FC min / FC max (bpm)	41 / 99
Index CVHR (oscillations FC)	32,3 /h	Index PWAD (micro-éveils aut.)	35,2 /h
IMC (kg/m ²)	32,9	Durée max Apnée (s)	—
Durée max Hypopnée (s)	53,8	Durée max Désaturation (s)	120,0

4. AVIS MÉDICAL ET CONDUITE À TENIR

1. Synthèse Polygraphique

Enregistrement nocturne continu de 9h 25min chez une patiente de 58 ans explorée pour rétrécissement anatomique de l'isthme pharyngé (IMC : 32,9 kg/m²) :

- **Absence de critères pour un SAHOS significatif** : L'indice d'apnées-hypopnées est normalisé (IAH = **2,1/h**, seuil < 5/h), sans apnée obstructive ni centrale (IA = 0,0/h). Les 20 hypopnées enregistrées sont isolées et courtes (moyenne : 23,2 s).
- **Dissociation oxymétrique / ventilatoire** : La saturation moyenne reste satisfaisante à **97%** avec un temps d'hypoxie négligeable (**T90 = 0,1%**). Toutefois, l'index de désaturation est discrètement élevé (**IDO = 6,6/h**, atteignant **9,3/h** en décubitus latéral droit). Ce profil de désaturations sans réduction de débit atteignant le seuil conventionnel d'hypopnée traduit des épisodes de limitation de débit inspiratoire ou d'hypoventilation positionnelle.
- **Forte instabilité neuro-végétative et motrice** : Présence d'un nombre élevé de micro-réveils autonomiques vasculaires (**PWAD à 35,2/h**), d'oscillations du rythme cardiaque (**CVHR à 32,3/h**) et d'une agitation motrice nocturne (2116 mouvements actimétriques). Dans ce contexte d'obstacle anatomique pharyngé, cette triade oriente vers un **Syndrome de Haute Résistance des Voies Aériennes Supérieures (SHRVAS / RERAs)** ou une fragmentation motrice du sommeil.